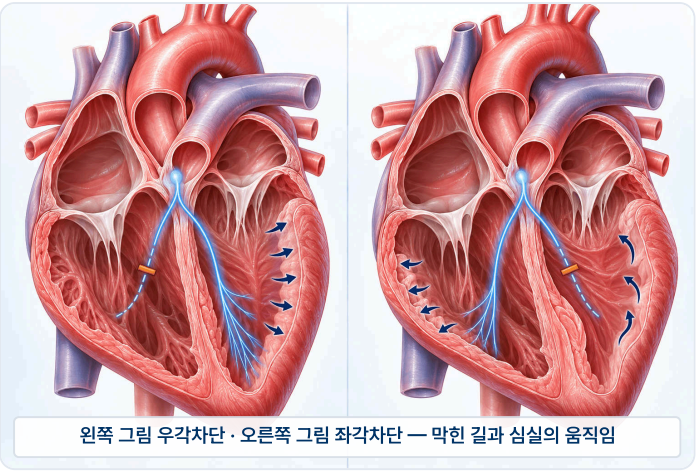
심전도에 각차단이 있대요 — 우각차단과 좌각차단

각차단은 심전도에서 QRS(심실이 수축할 때 나타나는 큰 파형)의 폭이 넓어진 소견입니다. 우각차단은 별다른 증상이 없으면 추가 검사 없이 경과를 지켜보고, 좌각차단은 심장 초음파로 심장 상태를 확인한 뒤 정기적으로 추적합니다.

각차단이란 — 심실로 가는 전기 신호의 길 한쪽에 장애가 생긴 상태



왼쪽 그림 우각차단 · 오른쪽 그림 좌각차단 — 막힌 길과 심실의 움직임

심전도에서는 이렇게 보입니다

우각차단(RBBB)은 가슴 쪽 V1 유도에서 R파가 크게, **좌각차단(LBBB)**은 V1 유도에서 S파가 깊게 나타납니다. 두 경우 모두 **QRS의 폭이 정상보다 훨씬 넓어집니다.**

우각은 오른쪽 심실, 좌각은 왼쪽 심실로 가는 길입니다. 오른쪽에 생기면 **왼쪽 심실의 움직임에는 영향이 없어** 심장 기능에 크게 문제가 되지 않습니다. 왼쪽 길에 장애가 생기면 왼쪽 심실이 고르게 수축하지 못하고 **기우뚱기우뚱 뛰게 되어** 좌심부전(왼쪽 심장의 펌프 기능 저하)이 생길 수 있습니다.

겉으로는 멀쩡해 보여도 심전도에서 발견되는 경우가 많아, 스웨덴 중년 남성을 28년 가까이 추적한 연구에서 각차단 비율은 **50대 남성 약 1%, 80대 약 17%**였습니다.

28년 추적 연구로 본 차이 — 각차단이 없는 사람과 비교

각차단이 있는 비율
1% → 17%
50대 남성 → 80대 남성

우각차단 — 사망률·심질환
차이 없음
방실차단 약 3배 · 인공심박동기 약 5배

좌각차단 — 사망률
약 2배
심질환 2~5배 · 방실차단 16배 · 심박동기 11배

좌각차단 → 좌심실 수축 기능 저하로 진행
36%
QRS 폭이 정상인 군은 10% · 상대위험 3.78

방실차단은 윗방(심방)에서 아랫방(심실)으로 가는 전기 신호가 늦어지거나 끊기는 상태, **인공심박동기**는 맥박이 너무 느릴 때 전기 신호를 대신 보내 주는 기계입니다. 좌각차단의 사망률 증가는 관동맥질환(심장 혈관 병)에 의한 사망으로 정리되었습니다.

우각차단과 좌각차단 — 이렇게 다릅니다

구분	우각차단 (RBBB)	좌각차단 (LBBB)
심장 기능에 미치는 영향	오른쪽 심실의 길이라 왼쪽 심실 움직임에 영향이 없습니다. 장기 경과가 각차단 없는 사람과 차이가 없어 **대체로 큰 문제가 되지 않는 양성(benign) 소견**으로 보며, 증상이 없으면 경과만 지켜봅니다.	왼쪽 심실의 수축이 방해받아 **심부전이 늘고 사망률이 약 2배로 증가**합니다(슬라이드에는 2~3배로 정리). 이미 심근경색이나 심부전이 있는 분에게는 각차단이 있으면 사망률이 뚜렷하게 높아집니다.
숨은 질환과의 관계	일반인에게 흔히 보이며, 다른 이상 없이 단독으로 있으면 대부분 특별한 치료가 필요하지 않습니다. 다만 방실차단은 약 3배 늘어납니다.	대동맥판막 협착(심장 판막이 좁아지는 병), 허혈성 심질환(심장 혈관이 좁아져 생기는 병) 등 **숨어 있는 다른 질환과 연관이 많습니다.**
진료 대책	**별도의 증상이 없으면 추가 검사 없이 경과 관찰**합니다.	**처음에 심장 초음파를 반드시** 시행하고, 이후에도 정기적으로 추적합니다(뒷면).

심전도 결과지에 'ST-T 변화'가 함께 적혀 있다면

각차단이 있으면 협심증 같은 병이 없어도 **ST 분절이 내려가거나 T파가 뒤집히는 변화가 자연스럽게 생깁니다.** 연자는 이를 QRS 변화에 따라 수동적으로 따라오는 '이차 변화'라고 설명했습니다. 각차단이 없는데 ST-T만 따로 변했을 때와는 의미가 다르므로 결과지를 보여 주시고 진료 때 물어봐 주세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

뒷면 → 좌각차단이 있을 때 추적하는 법 · 우각차단 질의응답 · 다시 진료받아야 할 때

좌각차단이 있으면 이렇게 추적합니다

처음 초음파가 정상이어도 나중에 심부전이나 방실차단이 생길 수 있어 정기적으로 살핍니다.

좌각차단 추적 순서

1 처음 — 심장 초음파는 필수입니다

심전도로는 보이지 않는 **판막 이상과 심장 기능 이상**이 숨어 있는지 반드시 확인합니다. 지금 당장은 문제가 없어도 나중에 심부전이 뒤늦게 생길 수 있기 때문입니다.

2 처음 초음파가 정상이어도 — 1~2년에 한 번 정도

좌심 기능이 떨어지지 않는지, **심장이 커지지 않는지**를 심장 초음파로 봅니다. 좌각차단이 있으면 없는 분보다 좌심부전이 약 4배 더 많이 생긴다고 보고되었습니다.

3 나이가 들면서 — 홀터와 심장 초음파로 주기적 추적

나이 들어서는 방실차단의 비율이 **10배 이상** 늘 수 있어, 특히 고령에서는 홀터(하루 이상 계속 기록하는 심전도)와 심장 초음파로 **방실차단과 심부전이 생기는지** 주기적으로 살핍니다.

심부전이 심하게 나빠진 경우 — 양심실 조율(CRT)

좌심 기능이 아주 심하게 나빠지면 **왼쪽 심실과 오른쪽 심실에 전극을 넣어 심장이 조화롭게 뛰도록 하는 치료**(양심실 조율, CRT)가 필요한 경우가 있습니다. 좌각차단과 심부전이 함께 있고 적응증에 맞는 분은 **양심실 조율이 심부전을 호전시키고 생존율을 높인다**는 자료가 있다고 소개했습니다.

슬라이드의 적응증: 좌심실 박출률 **30~35% 이하** · 심부전 증상(NYHA 2 이상) · QRS 폭 **150msec 이상**. 해당 여부는 진료실에서 검사 결과를 보고 판단합니다.

우각차단 — 연수강좌 질의응답에서 연자가 답한 내용

질문	연자의 답변
건강검진에서 우각차단이나 불완전 우각차단이 나왔습니다. 심장 초음파 같은 추가 검사가 필요한가요?	연자는 **증상이 없는 단독 우각차단·불완전 우각차단은 흔하고, 다른 이상이 없으면 대부분 특별한 치료가 필요하지 않다**고 답했습니다. 심잡음·호흡곤란·실신이나 다른 심전도 이상이 없다면 심장 초음파를 반드시 할 필요는 없다고 했습니다. 반대로 **증상이 있거나 새로 생긴 우각차단, 심장 축 이상이나 방실 전도 이상이 함께 있는 경우, 구조적 심질환이 의심되는 경우**에는 초음파 같은 추가 평가가 필요합니다.
우각차단이 있는 분이 아주 오래 지켜보면 어떤가요?	5년 이상(10~20년) 아주 길게 추적하면 완전 방실차단이 일반인보다 **3~5배** 다소 높게 나타날 수 있다고 합니다. 다만 절대적인 발생 빈도는 매우 낮아 **정기적인 심전도나 홀터 검사는 필요하지 않고, 증상의 변화가 있을 때 다시 방문**하시도록 권하면 좋겠다고 답했습니다.
우각차단에서 가슴 오른쪽(V2~V3) T파 뒤집힘이 2mm 넘게 깊습니다. 괜찮은가요?	우각차단에서는 V1~V3의 ST 하강과 T파 뒤집힘이 QRS 변화에 따른 전형적인 이차 변화일 수 있고, **깊이가 2mm 이상이라는 이유만으로 곧바로 허혈(혈액 부족)로 판단하지는 않는다**고 답했습니다. 다만 V4 이후까지 넓게 이어지거나, 새로 생긴 변화이거나, 흉통·실신이 함께 있으면 추가 평가가 필요합니다.

! 이럴 때는 다시 진료받아 주세요

- **숨이 차거나, 실신(정신을 잃음), 가슴 통증**이 새로 생겼을 때, 또는 증상이 달라졌을 때
- 이미 심근경색이나 심부전을 진단받은 분은 각차단이 함께 있다는 사실을 진료 때 꼭 알려 주세요. 궁금한 점은 심전도 결과지와 함께 물어보세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

근거 — 스웨덴 Göteborg 중년 남성 28년 추적 연구(Eur Heart J 2005) · 좌각차단과 좌심실 수축 기능 저하 연구(Am J Cardiol 2017) — 강의 슬라이드

본 자료는 각차단에 대한 일반 안내입니다. 나이, 증상, 심장 초음파 결과에 따라 추적 간격과 치료가 달라지니 진료 때 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/cardio/asl28-bundle-branch-block/